

TÀI LIỆU HỖ TRỢ NGƯỜI CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH



SẢ SÚT TRÍ TUỆ

DÙNG TRONG LỚP HỌC HỖ TRỢ
NGƯỜI CHĂM SÓC

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - 2020



Hội bệnh Alzheimer
và Rối loạn Thần kinh
Nhận thức Việt Nam



Đơn vị Trí nhớ và
Sa sút Trí tuệ
BỆNH VIỆN 30-4

LỜI GIỚI THIỆU

Ai rồi cũng qua chặng đường già lão với nhiều cung bậc buồn vui trong cuộc sống. Gia đình nào cũng sẽ có những người bước đến tuổi già. Một số người ngày ngày minh mẫn nhưng cũng có một số người đi dần vào sự lãng quên. Đó là những điều mà chúng ta đã, đang và sẽ đối mặt khi tuổi già kéo đến.

Một ngày nào đó, ông bà, cha mẹ, chú dì hoặc vợ chồng của bạn trở nên mất dần trí nhớ, bạn sẽ đối mặt với một bệnh lý thường gặp của tuổi già, đó là bệnh lý sa sút trí tuệ. Bệnh lý này sẽ làm cho người bệnh quên nhiều điều bình thường trong cuộc sống, không còn nhận biết người thân, không sẵn sóc được gia đình và thậm chí những vấn đề cơ bản trong sinh hoạt như ăn uống tắm ngủ cũng không làm được. Người bệnh trở nên nổi loạn, chống lại mọi sự chăm sóc của người thân, làm cho cuộc sống của gia đình đảo ngược và bế tắc.

Những ai có người thân bị bệnh lý sa sút trí tuệ chắc rằng sẽ trải qua những mệt mỏi và vô vọng này. Có những người khi tham gia các buổi nói chuyện về chăm sóc người bệnh sa sút trí tuệ đã bật khóc vì sự đơn độc trong công cuộc níu kéo người thân mình trở về thực tại bình thường.

KHÔNG, các bạn sẽ không còn đơn độc trong cuộc chiến này. hãy cùng với chúng tôi tham gia vào hành trình hỗ trợ người chăm sóc người bệnh sa sút trí tuệ.

Tập tài liệu các bạn đang cầm trong tay sẽ là những kiến thức mà chúng ta cần nắm vững để cùng nhau xây dựng nên các khóa học hỗ trợ người chăm sóc thật hiệu quả. Chúng tôi sẽ lần lượt đưa đến cho các bạn, những người chăm sóc người bệnh sa sút trí tuệ, những vấn đề như sau:

- **Hiểu biết về bệnh lý sa sút trí tuệ [Trang 4](#)**
- **Những thay đổi cần lưu ý của người bệnh sa sút trí tuệ [Trang 14](#)**
- **Lập kế hoạch chăm sóc [Trang 19](#)**
- **Chăm sóc người bệnh sa sút trí tuệ [Trang 24](#)**
- **Xử lý các tình huống phát sinh trong chăm sóc người bệnh sa sút trí tuệ [Trang 28](#)**
- **Nhận biết và xử lý thay đổi mối quan hệ của người bệnh sa sút trí tuệ với mọi người xung quanh [Trang 33](#)**
- **Những điều người chăm sóc cần làm cho bản thân [Trang 38](#)**

Người bệnh sa sút trí tuệ mất đi trí nhớ và nhận thức, nhưng họ vẫn còn tràn đầy sự cảm nhận. Hãy dang tay ôm lấy người thân mình, vỗ về để xoa dịu nỗi đau và bức xúc của họ, nâng đỡ để giữ lại những phần còn lại của trí não và cùng nhau sống một cuộc sống đầy hiểu biết và yêu thương.

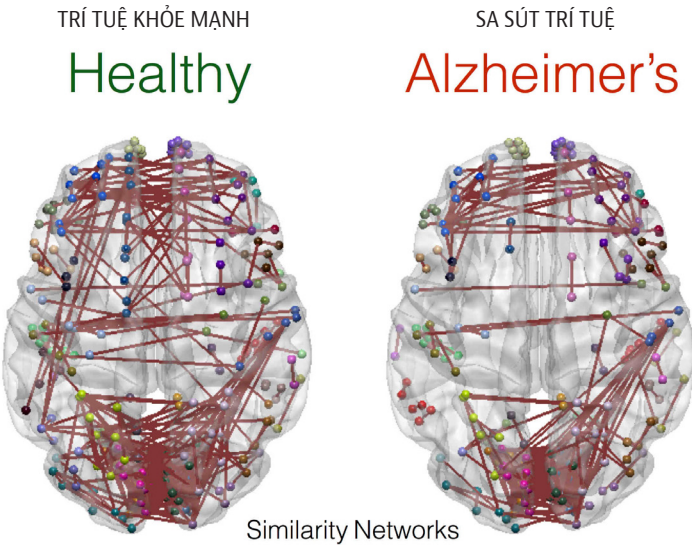


HIỂU BIẾT VỀ BỆNH LÝ SA SÚT TRÍ TUỆ

1. Sa sút trí tuệ là gì

Sa sút trí tuệ (SSTT) là bệnh lý của não bộ do các tế bào thần kinh bị chết đi quá nhiều gây ra. Bệnh gây ra chứng mất trí nhớ, suy nghĩ sai lầm và các hoạt động sinh hoạt của cá nhân không phù hợp làm ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày và các mối quan hệ xã hội của người bị bệnh.

Mặc dù SSTT nói chung liên quan đến mất trí nhớ, mất trí nhớ có những nguyên nhân khác nhau. Nếu chỉ có triệu chứng mất trí nhớ thì không có nghĩa là người đó bị sa sút trí tuệ.



NEWSNETWORK.MAYOCLINIC.ORG

Bệnh Alzheimer là nguyên nhân phổ biến nhất của chứng mất trí tiến triển ở người lớn tuổi, nhưng có một số nguyên nhân khác cũng gây sa sút trí tuệ. Trong một số trường hợp, bệnh Alzheimer và chứng mất trí nhớ mạch máu có thể xảy ra cùng nhau trong một tình trạng gọi là “chứng mất trí hỗn hợp”. Các nguyên nhân khác của chứng mất trí nhớ bao gồm chứng mất trí thùy trán, chứng mất trí nhớ với thể Lewy, bệnh Creutzfeldt-Jakob và bệnh Parkinson. Ngoài ra một số tình trạng bệnh lý nội khoa cũng gây ra sa sút trí tuệ, tùy thuộc vào nguyên nhân mà một số triệu chứng SSTT có thể hồi phục.

Một số nguyên nhân gây ra chứng mất trí nhớ hoặc các triệu chứng giống như mất trí nhớ có thể được đảo ngược bằng điều trị như:

- Nhiễm trùng và rối loạn miễn dịch.
- Vấn đề trao đổi chất và bất thường nội tiết như suy giáp, đái tháo đường, rối

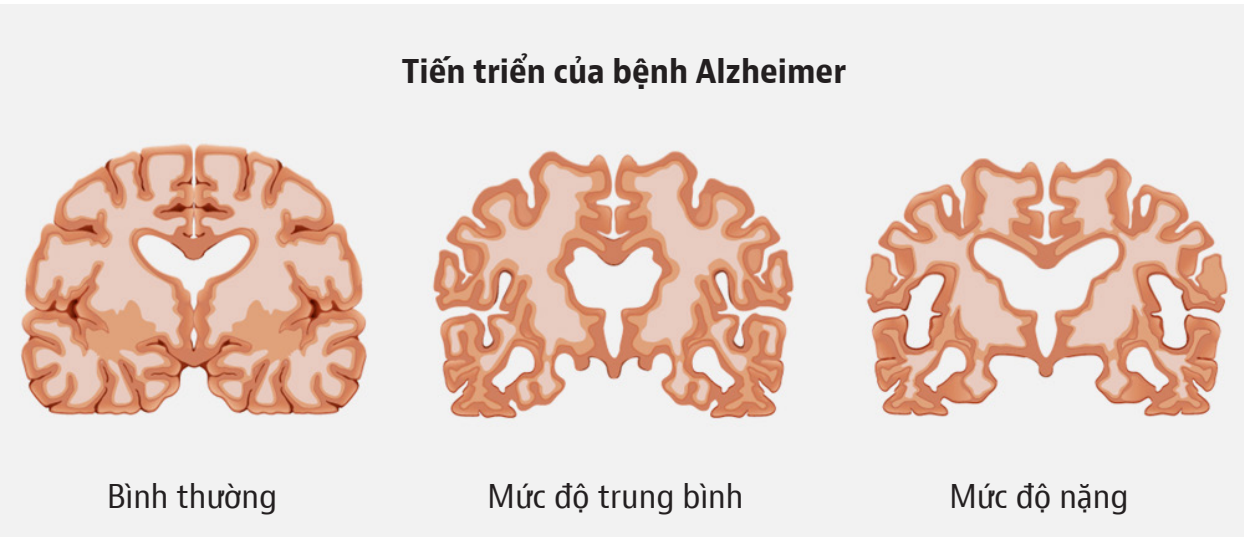
loạn điện giải, rối loạn hấp thu vitamin B-12, B1, B6, đồng, vitamine E...

- Tác dụng phụ của một số loại thuốc, đặc biệt là các loại thuốc hướng thần, gây nghiện.
- Tụ máu dưới màng cứng, thường gặp ở người cao tuổi sau khi ngã, có thể gây ra các triệu chứng tương tự như chứng sa sút trí tuệ.
- Ngộ độc do tiếp xúc với kim loại nặng, chẳng hạn như chì và các chất độc khác như thuốc trừ sâu, thuốc hướng thần hoặc uống rượu nhiều có thể dẫn đến các triệu chứng sa sút trí tuệ.
- U não. Chứng mất trí có thể xảy ra do tổn thương do khối u não gây ra.
- Thiếu oxy não. Tình trạng này xảy ra khi các mô cơ quan không nhận đủ oxy. Thiếu oxy não có thể xảy ra do ngưng thở khi hen suyễn, đau tim, ngộ độc khí CO hoặc các nguyên nhân khác.

2. Bệnh Alzheimer là gì

Bệnh Alzheimer là một bệnh lý thoái hóa của não bộ. Bệnh tiến triển dần dần phá hủy trí nhớ và khả năng học hỏi, suy luận, phán đoán, giao tiếp và thực hiện các hoạt động hàng ngày của người bệnh. Khi bệnh Alzheimer tiến triển, bệnh nhân cũng trải qua những thay đổi về tính cách và hành vi như lo lắng, nghi ngờ hoặc kích động, cũng như ảo tưởng hoặc ảo giác.

Mặc dù hiện tại chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu cho bệnh Alzheimer nhưng các thuốc, liệu pháp điều trị mới cùng nhiều nghiên cứu đang được tiến hành đẩy nhanh sự hiểu biết sâu sắc về sinh bệnh học của căn bệnh này. Nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng chăm sóc và hỗ trợ hiệu quả có thể cải thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân và những người chăm sóc họ trong suốt quá trình bệnh từ chẩn đoán đến cuối đời.



DRUGWATCH.COM

Tiến triển của bệnh Alzheimer

Bệnh Alzheimer tiến triển ở các mức độ khác nhau, thời gian mắc bệnh thường có thể thay đổi từ 3 đến 20 năm. Các khu vực của não kiểm soát trí nhớ và kỹ năng tư duy bị ảnh hưởng đầu tiên, nhưng khi bệnh tiến triển, các vùng não khác cũng sẽ bị tổn thương. Người mắc bệnh Alzheimer sẽ cần được chăm sóc toàn diện trong giai đoạn cuối vì mất khả năng chăm sóc bản thân, bệnh nhân không tử vong vì các bệnh lý khác thì việc mất chức năng não sẽ gây các rối loạn, mất chức năng sinh tồn dẫn đến việc bệnh nhân tử vong.

3. Tại sao cần chẩn đoán và điều trị sớm sa sút trí tuệ

Chẩn đoán sớm rất quan trọng với người bị sa sút trí tuệ. Cá nhân bệnh nhân hoặc thành viên gia đình của họ nên tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa nội thần kinh, bác sĩ – chuyên viên ở các đơn vị trí nhớ, sa sút trí tuệ hoặc bác sĩ gia đình, bác sĩ khám bệnh khi họ bắt đầu nhận thấy các triệu chứng như mất trí nhớ, phán đoán và suy luận, khó khăn với các công việc hàng ngày và thay đổi khả năng giao tiếp, tâm trạng và hành vi.

Tìm ra nguyên nhân của các triệu chứng có thể giúp người bệnh có sự chăm sóc, điều trị, hỗ trợ và cùng với thân nhân có kế hoạch thích hợp cho tương lai.

4. Các triệu chứng và các dấu hiệu của sa sút trí tuệ cần quan tâm để được khám và chẩn đoán sớm

Mất khả năng ghi nhớ các thông tin mới. Mặc dù việc quên các cuộc hẹn, tên hoặc số điện thoại hoặc các thông tin mới hàng ngày là bình thường, nhưng những người bệnh SSTT sẽ quên những điều đó thường xuyên hơn và không có khả năng ghi nhớ chúng cho dù được gợi nhắc.

Các Dấu Hiệu Của Sa Sút Trí Tuệ



Khó thực hiện các hoạt động, công việc hay nhiệm vụ quen thuộc. Người bệnh SSTT có thể bị quên các bước chuẩn bị bữa ăn, sử dụng thiết bị gia dụng hoặc thực hiện những công việc thường nhật một cách dễ dàng như trước đây.

Gặp khó khăn với ngôn ngữ. Người bệnh SSTT và nhất là bệnh Alzheimer thường quên một từ đơn giản hoặc thay thế một từ bất thường, khiến cho lời nói hoặc chữ viết của họ bị khó hiểu.

Mất phương hướng đến thời gian và địa điểm. Người mắc bệnh SSTT có thể bị lạc trên đường về nhà của chính họ. Họ có thể quên nơi họ ở, làm việc và định hướng để họ đến đó, không biết làm thế nào để trở về nhà. Thời gian ngày tháng, năm, mùa trong năm cũng không được bệnh nhân ghi nhớ, nhận biết dẫn đến những sai lầm, khó khăn khi giao tiếp, hoạt động xã hội.

Cư xử không phù hợp. Đánh giá hoàn cảnh và có những cử xử không thích hợp, dễ gây tổn hại cho bản thân người bệnh hoặc gây mâu thuẫn, tranh cãi với người xung quanh. Những người mắc bệnh có thể ăn mặc mà không quan tâm đến thời tiết, mặc nhiều áo vào ngày nóng hoặc mặc rất ít quần áo trong thời tiết lạnh.

Mất khả năng lên kế hoạch thực hiện. Những người SSTT thường thể hiện sự quản lý kém về tiền bạc, dành một khoản tiền lớn cho các sản phẩm, dịch vụ họ không cần, quên các tài sản hay tài khoản cá nhân.

Mất khả năng với tư duy. Người bệnh khó phải tư duy như việc gán ý nghĩa các con số, hình ảnh cho một sự vật. Những vấn đề phải giả định, hình dung là điều khó khăn cho người bệnh.

Nhầm lẫn vị trí, quên vị trí đồ đạc nơi ở, làm việc. Bất cứ ai cũng có thể tạm thời đặt nhầm ví hoặc chìa khóa nhưng người bị sa sút trí tuệ có thể đặt mọi thứ ở những nơi khác thường, như một đồng hồ trong tủ lạnh hoặc chìa khóa để trong lò nướng. Chính sự nhầm lẫn này sẽ có thể gây ra thiệt hại, nguy hiểm khi không có sự giám sát.

Thay đổi tâm trạng hoặc hành vi. Người bị SSTT có thể trở nên buồn bã hoặc ủ rũ theo thời gian, biểu hiện sự thay đổi tâm trạng nhanh chóng - từ bình tĩnh đến khóc lóc hoặc đến tức giận - không có lý do rõ ràng. Cũng chính điều này dẫn đến người bệnh hay bị chẩn đoán mắc phải các bệnh lý tâm thần, và việc điều trị các thuốc hướng thần lại gây nên tình trạng bệnh càng nặng hơn hoặc thân nhân, những người xung quanh có sự sợ hãi, lo lắng vì sự thay đổi hành vi của bệnh nhân.

Thay đổi tính cách. Tính cách thường thay đổi phần nào theo tuổi tác tuy nhiên một người SSTT có thể thay đổi trở nên cực kỳ bối rối, nghi ngờ, sợ hãi hoặc phụ thuộc vào một thành viên trong gia đình. Điều này khiến cho chính các thành viên gặp khó khăn trong việc sắp xếp cuộc sống của họ để chăm sóc, hỗ trợ bệnh nhân, tạo gánh nặng trong tâm lý khi chăm sóc người bệnh sa sút trí tuệ.

Thụ động, mất hẳn sự chủ động trong hoạt động hàng ngày. Tuy đối với người bình thường đôi khi áp lực của công việc gia đình, hoạt động kinh doanh hoặc các nghĩa vụ xã hội vào những thời điểm khiến người ta trở nên thụ động, không thích tham gia các hoạt động bên ngoài nhưng đối với người sa sút trí tuệ có thể trở nên rất thụ

động, ngồi trước tivi hàng giờ, ngủ nhiều hơn bình thường hoặc không muốn tham gia các hoạt động của gia đình, xã hội trong thời gian dài.

Nếu bạn nhận ra bất kỳ dấu hiệu cảnh báo nào ở bản thân hoặc người thân, chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ, nhất là ở chuyên khoa Nội thần kinh hoặc Đơn vị trí nhớ và sa sút trí tuệ. Chẩn đoán sớm bệnh Alzheimer hoặc các rối loạn khác gây mất trí nhớ là một bước quan trọng để có được các dịch vụ điều trị, chăm sóc và hỗ trợ phù hợp cho cả bệnh nhân lẫn thân nhân, người chăm sóc và có thời gian để lên kế hoạch cho tương lai một cách hợp lý.

5.Chẩn đoán sa sút trí tuệ

Hiện tại ở Đơn vị trí nhớ và Sa sút trí tuệ Bệnh viện 30-4 (với sự giúp đỡ của các chuyên gia của trung tâm DZNE từ CHLB Đức trong dự án TEEM) với quy trình chẩn đoán như sau:

- Kiểm tra sức khỏe tổng quát của bạn.
- Hỏi các câu hỏi về bệnh sử gia đình.
- Hỏi người nhà về biểu hiện trí nhớ của bạn
- Thực hiện các bài đánh giá về trí nhớ và kỹ năng của bạn
- Làm các xét nghiệm máu và nước tiểu
- Chụp hình kiểm tra não bộ của bạn (CTScan hoặc MRI não)



WWW.KABELAW.COM

6.Các giai đoạn suy giảm nhận thức và sa sút trí tuệ

Giai đoạn 1: Không suy giảm trí nhớ (chức năng bình thường)

Người bệnh không gặp vấn đề trở ngại về trí nhớ và không có gì là rõ ràng khi thăm khám, thậm chí với việc thực hiện các bảng câu hỏi trắc nghiệm thần kinh tâm lý người bệnh cũng dễ dàng vượt qua.

Giai đoạn 2: Suy giảm nhận thức rất nhẹ (thay đổi liên quan đến tuổi bình thường)

Người bệnh có thể cảm thấy như thể họ có vấn đề về trí nhớ, đặc biệt là quên những từ hoặc tên quen thuộc hoặc vị trí của chìa khóa, kính mắt hoặc các vật dụng hàng ngày khác. Những thay đổi này có thể rõ ràng với bạn bè, gia đình hoặc đồng nghiệp tuy nhiên người bệnh vẫn duy trì được các sinh hoạt xã hội, cá nhân hàng ngày.

Giai đoạn 3: Suy giảm nhận thức nhẹ

Bạn bè, gia đình hoặc đồng nghiệp bắt đầu nhận thấy sự thiếu sót. Những khó khăn thường gặp bao gồm:

- Bắt đầu có các biểu hiện khó khăn sử dụng ngôn ngữ: dùng từ không phù hợp, dùng từ tối nghĩa hoặc diễn đạt khó hiểu dù nội dung không quá phức tạp khiến việc giao tiếp bắt đầu có trở ngại
- Giảm khả năng nhớ tên khi được giới thiệu người mới, đồ vật mới.
- Giảm khả năng thực hiện công việc.

Giai đoạn 4: Sa sút trí tuệ mức độ nhẹ

Ở giai đoạn này, thăm khám lâm sàng và kết quả các test thần kinh tâm lý cho thấy có dấu hiệu rõ ràng:

- Giảm trí nhớ, nhận thức về các sự kiện gần đây hoặc các sự kiện vừa xảy ra.
- Giảm khả năng tính toán, tư duy để thực hiện các tính toán (ví dụ, đếm ngược dãy số, 100 trừ dần đi 7)
- Giảm khả năng thực hiện các nhiệm vụ phức tạp, như lên kế hoạch cho bữa tối của gia đình cần tiếp khách hoặc quản lý tài chính của cá nhân, gia đình.
- Giảm trí nhớ cá nhân: các sự kiện liên quan đến bản thân, gia đình.
- Gặp khó khăn trong giao tiếp xã hội, gia đình do vấn đề nhận thức suy giảm, có mâu thuẫn do giao tiếp giữa người bệnh và người xung quanh không phù hợp.

Giai đoạn 5: Sa sút trí tuệ mức độ trung bình



VECTORSTOCK.COM

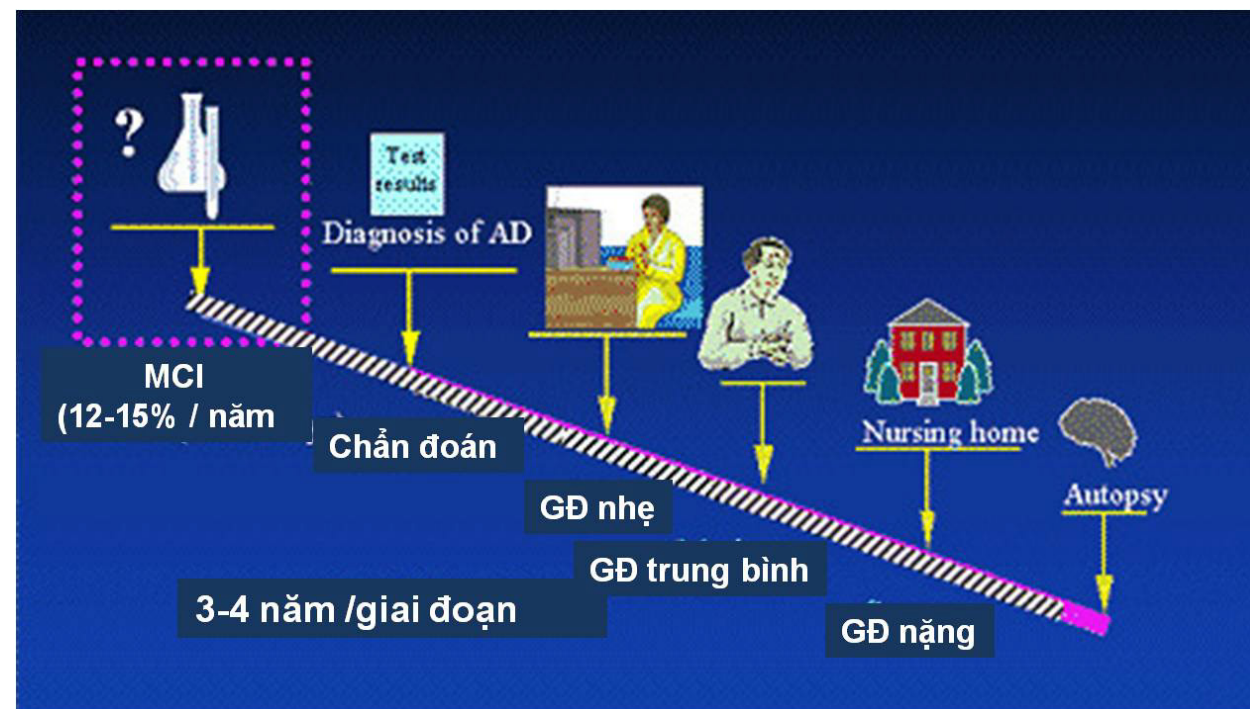
Những khoảng trống lớn trong bộ nhớ và sự thiếu hụt trong chức năng nhận thức xuất hiện. Người bệnh bắt đầu cần sự hỗ trợ của thân nhân, người chăm sóc trong các hoạt động xã hội lẫn chăm sóc cá nhân. Ở giai đoạn này người bệnh có thể:

- Không thể nhớ lại các chi tiết quan trọng như địa chỉ hiện tại, số điện thoại hoặc tên của trường đại học/ trung học họ đã tốt nghiệp.
- Trở ngại khi nói về nơi ở hoặc về ngày, ngày trong tuần (khó khăn trong định hướng không gian, thời gian).
- Gặp khó khăn với việc tính toán kể cả tính toán đơn giản như 2×2 ; 4×4 ; đếm số chẵn lẻ...
- Cần giúp chọn quần áo phù hợp cho thời tiết hoặc sự kiện tham gia.
- Thường vẫn giữ lại kiến thức, ký ức đáng kể về bản thân và biết tên của chính mình và tên của vợ / chồng hoặc con cái của mình.
- Thường vẫn tự chăm sóc bản thân được.

Giai đoạn 6: Sa sút trí tuệ mức độ nặng

Khó khăn về trí nhớ tiếp tục có những ảnh hưởng xấu đi, có những thay đổi hành vi, tính cách và người bệnh cần sự giúp đỡ trong các hoạt động hàng ngày. Ở giai đoạn này, người bệnh có thể:

- Mất hầu hết nhận thức về những trải nghiệm và sự kiện gần đây cũng như nhận thức hiện tại về môi trường xung quanh.
- Nhớ lại ký ức cá nhân của họ một cách không hoàn thiện, mặc dù thường nhớ lại tên của chính mình.



- Thỉnh thoảng quên tên của vợ/chồng hoặc người chăm sóc chính nhưng thường có thể phân biệt người quen – người lạ.
- Cần giúp mặc quần áo đúng cách: không có sự giám sát, có thể mặc áo quần không đúng.
- Thay đổi chu kỳ ngủ / thức dậy.
- Cần giúp đỡ trong việc vệ sinh cá nhân.
- Tăng các đợt tiểu không tự chủ hoặc đại tiện.
- Bắt đầu có những thay đổi về tính cách và các triệu chứng hành vi, bao gồm sự nghi ngờ và ảo tưởng (ví dụ: cho người chăm sóc họ là kẻ mạo danh, ghen tuông, nghi ngờ quá mức); ảo giác: nhìn hoặc nghe thấy những thứ không thực sự ở đó; hoặc các hành vi bất buộc, lặp đi lặp lại như vắt tay hoặc hỏi một câu hỏi)
- Có xu hướng đi lang thang và bị lạc.

Giai đoạn 7: Sa sút trí tuệ giai đoạn cuối

Đây là giai đoạn cuối của bệnh khi các người bệnh mất khả năng phản ứng với môi trường, khả năng nói, giao tiếp và cuối cùng là khả năng kiểm soát hoạt động của chính mình.

- Mất khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ.
- Cần giúp đỡ trong việc ăn uống và đi vệ sinh và tiểu không tự chủ.
- Mất khả năng đi lại, sau đó là khả năng ngồi.
- Mất các khả năng biểu lộ tình cảm, cảm xúc, giao tiếp bằng cơ thể, mất khả năng ngẩng cao đầu.
- Phản xạ trở nên bất thường và rối loạn trương lực cơ.
- Rối loạn các chức năng sinh tồn: nhai, nuốt...

7. Điều trị sa sút trí tuệ

Hiện tại việc điều trị tốt nhất là phối hợp giữa điều trị dùng thuốc và không dùng thuốc để giúp BN làm chậm diễn tiến của bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm thiểu hay ngăn ngừa các rối loạn hành vi.

Tùy thuộc vào nguyên nhân sa sút trí tuệ mà có phương pháp điều trị phù hợp. Nếu do các bệnh lý có thể điều trị như nhiễm trùng, thiếu hụt vitamin, bệnh lý tâm thần, bệnh lý mạch máu... thì việc điều trị nguyên nhân có thể giúp đảo ngược tình trạng sa sút trí tuệ

Đối với sa sút trí tuệ do bệnh lý Alzheimer (nguyên nhân hàng đầu của sa sút trí tuệ) thì việc điều trị hiện tại chưa có thuốc đặc hiệu tuy nhiên phối hợp các phương pháp dùng thuốc và không dùng thuốc có thể cải thiện tình trạng của BN, kéo dài thời

gian duy trì chất lượng cuộc sống.

Điều trị dùng thuốc: Các nhà nghiên cứu tiếp tục tìm kiếm các phương pháp điều trị mới để thay đổi tiến trình của bệnh và các chiến lược khác để cải thiện chất lượng cuộc sống cho những người bị sa sút trí tuệ.

Thuốc theo toa: Hiện tại có hai nhóm thuốc hiện đang được kê đơn để điều trị Alzheimer:

- 1/ Thuốc ức chế men Cholinesterase: Aricept (Donepezil), Exelon (Rivastigmine) và Reminyl (Galantamine).
- 2/ Thuốc tác động NMDA Receptor: Ebixa (Memantine).

Các tác dụng phụ phổ biến nhất của Aricept , Exelon và Reminyl là buồn nôn, nôn, chán ăn và tiêu chảy. Các tác dụng phụ phổ biến nhất của Namenda là chóng mặt, nhức đầu và táo bón. Khi chúng xảy ra, những triệu chứng này có xu hướng nhẹ và thoáng qua, tuy nhiên cần liên hệ ngay với bác sĩ điều trị để có điều chỉnh phù hợp nhất.

Điều trị không dùng thuốc: Các bài tập hoạt động trị liệu, các liệu pháp y học cổ truyền, các bài tập thể dục hàng ngày và sự chăm sóc đầy yêu thương của người thân có tác dụng rất cao trong gìn giữ trí nhớ của người bệnh.

Âm nhạc, nghệ thuật và các liệu pháp khác

Âm nhạc, nghệ thuật, chăm sóc thú cưng và các loại trị liệu khác có thể giúp làm phong phú thêm cuộc sống của những người mắc bệnh. Chăm sóc thú cưng đã được chứng minh là làm giảm trầm cảm và tăng cường lòng tự trọng. Nghệ thuật cung cấp một lối thoát cho sự thể hiện. Âm nhạc khuấy động ký ức, cảm xúc và khi được hát, khuyến khích các hoạt động nhóm để nâng cao tương tác cho người bệnh.

Âm nhạc trị liệu:

Xác định âm nhạc quen thuộc và thuộc thể loại yêu thích với người nghe.

- Sử dụng âm nhạc để tạo ra tâm trạng bạn muốn.
- Liên kết âm nhạc với các hoạt động hồi tưởng khác; sử dụng câu hỏi hoặc hình ảnh để giúp khuấy động ký ức.
- Khuyến khích phong trào (vỗ tay, nhảy múa) để tăng thêm sự thích thú.
- Tránh quá tải cảm giác; loại bỏ tiếng ồn bằng cách đóng cửa sổ và cửa ra vào và tắt tivi khi mở nhạc

Nghệ thuật trị liệu:

Cần hiểu là người bệnh lớn tuổi không phải trẻ em, giữ mức độ khó cho người lớn. Tránh sử dụng bút màu sáp nhỏ trên các tờ giấy vẽ của trẻ em (có in các chữ trên tờ giấy hay sách cho trẻ)

- Khuyến khích, thảo luận về những gì người bệnh đang tạo ra và cố gắng bắt đầu một chút kể chuyện sáng tạo hoặc hồi tưởng.

- Nên yêu cầu cơ bản, chỉ hỗ trợ khi cần chứ không làm thay.
- Sử dụng vật liệu an toàn. Tránh các chất độc hại và dụng cụ sắc nhọn.
- Cho thời gian đủ để hoàn thành dự án nghệ thuật và có thể theo từng phần, từng ngày chứ không bắt buộc phải hoàn thành ngay trong 1 lần.

Và hãy nhớ rằng: Tác phẩm nghệ thuật “hoàn thành” khi người bệnh nói hoàn thành chứ không theo nguyên tắc nào cứng nhắc!



NHỮNG THAY ĐỔI QUAN TRỌNG CẦN LƯU Ý CỦA NGƯỜI BỆNH SA SÚT TRÍ TUỆ

1. Khó khăn trong điều khiển các phương tiện giao thông

Điều khiển phương tiện giao thông, nhất là tại các khu vực dân cư đông như Hà Nội, Tp HCM là một hoạt động phức tạp đòi hỏi các phản ứng nhanh, các giác quan cảnh giác và ra quyết định chính xác. Đối với một người sa sút trí tuệ, việc lái xe chắc chắn trở nên khó khăn.

Chẩn đoán SSTT không có nghĩa là người đó mất hết khả năng lái xe. Tuy nhiên không nên để người SSTT lái xe một mình, không theo có sự giám sát, theo dõi. Thân nhân hay người chăm sóc nên đánh giá người đó thường xuyên để xác định xem có an toàn cho người đó lái xe hay không.

Các dấu hiệu cảnh báo lái xe không an toàn:

- Quên cách xác định vị trí.
- Không quan sát tín hiệu giao thông.
- Đưa ra quyết định chậm hoặc kém.
- Lái xe ở tốc độ không phù hợp, không theo biển hướng dẫn.
- Không nhớ ý nghĩa các biển hướng dẫn, các quy tắc giao thông.
- Trở nên tức giận và bối rối khi lái xe.

Đối với nhiều người, việc hạn chế đặc quyền lái xe biểu thị sự mất độc lập, cảm giác phụ thuộc và không được tự quyết định việc di chuyển của bản thân. Cảm giác không thoải mái này có thể làm những người sa sút trí tuệ không từ bỏ việc lái xe.

Một số gợi ý để hạn chế người sa sút trí tuệ lái xe:

- Yêu cầu bác sĩ viết đề nghị có giám sát khi lái xe trong toa thuốc.
- Vô hiệu hóa xe bằng cách gắn một số linh kiện khiến xe không thể hoạt động.
- Cất xe ở vị trí không quen thuộc, cất xe nơi khác chỗ ở.
- Sắp xếp sử dụng các phương tiện giao thông khác.

2. Đảm bảo an toàn trong nhà

Khi chăm sóc một người sa sút trí tuệ tại nhà, sự an toàn, tiện dụng và thoải mái là mối quan tâm lớn nhất.

- Hạn chế những vị trí nguy hiểm (nguy cơ té ngã, chấn thương cao)

- Khóa hoặc nguy trang khu vực nguy hiểm (cầu thang, khu để đồ dễ vỡ, rơi ngã...)
- Lắp khóa cửa khuất tầm nhìn.
- Sử dụng các thiết bị an toàn đặc biệt, chẳng hạn như khóa chống khóa trái cửa, khóa những nơi lưu trữ dao, thiết bị điện và chất tẩy rửa.

3. Thích nghi cho những thay đổi thị giác

- Hạn chế ánh sáng quá chói bằng cách loại bỏ hoặc che bớt kính cửa và đồ nội thất bằng kính, che cửa sổ bằng rèm hoặc màn cửa.
- Thêm đèn bổ sung ánh sáng đủ ở các khu vực giữa các phòng, cầu thang và phòng tắm vì sự thay đổi về mức độ ánh sáng các không gian trong nhà có thể làm họ bị mất phương hướng.
- Đặt thảm màu tương phản trước cửa hoặc các dấu hiệu khác nhau giúp nhận biết cầu thang, lối vào các phòng khác nhau.

4. Tránh sang chấn trong các hoạt động hàng ngày

- Theo dõi nhiệt độ của vòi nước và thức ăn vì người bệnh có thể bị giảm độ nhạy cảm với nhiệt độ.
- Lắp đặt vòi hoa sen có thể thay đổi độ cao thích hợp, dán đề can lên các bề mặt trơn trong phòng tắm để tránh ngã, lắp các thanh vịn khu vực vệ sinh, tắm rửa



để tránh trượt, té ngã.

- Các dụng cụ sắc nhọn hạn chế tuyệt đối việc sử dụng
- Giám sát dùng thuốc theo toa và thuốc không kê đơn. Không để người bệnh tự ý uống thuốc, các lọ thuốc để xa tầm với và tầm nhìn của người bệnh. Giám sát việc hút thuốc và uống rượu.
- Loại bỏ các đồ dùng trang trí không cần thiết như kệ tạp chí, bàn cà phê, kệ trang trí để tạo ra các khu vực an toàn và giảm khả năng chấn thương. Dùng các dụng cụ giảm bớt góc nhọn như góc bàn, góc cửa
- Làm sạch tủ lạnh thường xuyên và loại bỏ thực phẩm không ăn được.

5. Hãy chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp

- Dán danh sách các số điện thoại và địa chỉ khẩn cấp: cấp cứu, cứu hỏa, người thân cần liên hệ để khi có vấn đề xảy ra sẽ liên hệ được ngay.
- Kiểm tra bình chữa cháy và báo động khói thường xuyên.
- Thông báo cho hàng xóm, công an khu vực đề phòng trường hợp đi lạc.

6. Vệ sinh và chăm sóc cá nhân

Những người mắc bệnh SSTT có thể cần giúp đỡ trong các hoạt động thường ngày liên quan đến vệ sinh cá nhân, chăm sóc cơ thể. Nhu cầu hỗ trợ có thể rất khó khăn đối với họ vì nó biểu thị sự mất độc lập và riêng tư.

Người chăm sóc cũng gặp khó khăn, đặc biệt là khi họ hỗ trợ các hoạt động can thiệp vào quyền riêng tư của cá nhân như tắm và vệ sinh răng miệng.

Tắm

Tắm thường là hoạt động chăm sóc cá nhân khó khăn nhất mà người chăm sóc phải đối mặt. Bởi vì đó là một trải nghiệm thân mật, người mắc bệnh SSTT có thể cảm thấy nó là khó chịu, đe dọa hoặc đau đớn và thể hiện các hành vi gây rối như la hét, chống cự và đánh. Những hành vi này thường xảy ra bởi vì người SSTT không biết tắm là gì hoặc không đủ kiên nhẫn để chịu đựng những khía cạnh khó chịu như thiếu che chắn, lạnh lùng hay cảm thấy khó chịu. Hãy thử như sau:

- Làm mọi thứ bạn có thể trước để làm cho quá trình dễ dàng hơn, chẳng hạn như tăng nhiệt độ phòng và có khăn tắm gần đó.
- Làm cho người bệnh cảm thấy kiểm soát quá trình tắm. Tham gia và huấn luyện qua từng bước của quá trình. Có thể cần thử nghiệm để xác định người bệnh có thích tắm không? tắm bồn hay vòi sen? thời gian nào trong ngày là tốt nhất?
- Tạo một bầu không khí an toàn và hài lòng. Đặt chất chống dính / trượt trên bề mặt sàn và lấy các thanh trong bồn tắm để tránh rơi. Kiểm tra nhiệt độ nước

trước để tránh bị bỏng.

- Tôn trọng phẩm giá của người đó. Một số cá nhân có thể tự ý thức về sự trần trụi của họ. Cho phép người giữ một chiếc khăn trước cơ thể của họ, cả trong và ngoài khi tắm, có thể làm giảm sự lo lắng.
- Đừng lo lắng về tần suất tắm. Có thể không cần thiết phải tắm mỗi ngày. Tắm bồn có thể có hiệu quả giữa vòi hoa sen hoặc phòng tắm.
- Hãy nhẹ nhàng. Da của người đó có thể rất nhạy cảm, vì vậy tránh chà xát và lau khô da thay vì chà xát.
- Được linh hoạt. Bạn có thể gặp khó khăn nhất khi cố gắng gội đầu cho người bệnh. Sử dụng khăn mặt để xả phòng và xả tóc để giảm lượng nước trên mặt của người bệnh.

Một số lưu ý khi sử dụng nhà tắm:

- Đặt các biển báo dễ nhận diện, hỗ trợ người bệnh dễ dàng trong việc tìm kiếm phòng tắm. Đặt thảm màu trên sàn phòng tắm và nắp đậy trên nhà vệ sinh có thể giúp phòng tắm nổi bật. Tránh để các vật dụng có thể bị nhầm lẫn với nhà vệ sinh, chẳng hạn như thùng rác, giỏ quần áo...
- Theo dõi tiêu tiểu không tự chủ. Xác định thời gian thường xảy ra và lập kế hoạch phù hợp.
Ví dụ, nếu cứ sau 2-3h ăn uống thì người bệnh sẽ tiêu tiểu không tự chủ thì sẽ có kế hoạch đưa người đó đi vệ sinh trước thời gian đó. Để giúp kiểm soát tình trạng tiểu không tự chủ vào ban đêm, hãy hạn chế uống sau khi ăn tối.
- Lựa chọn sẵn quần áo dễ dàng cho việc mặc và thay.
- Luôn nhắc nhở vì người bệnh SSTT có thể quên đi vệ sinh, tắm rửa, bạn có thể phải nhắc nhở người đó định kỳ. Đồng thời theo dõi các dấu hiệu có thể nhìn thấy như bồn chồn hoặc nét mặt có thể cho thấy người đó cần đi vệ sinh.
- Hãy tôn trọng và thể hiện sự hỗ trợ! Giúp người bệnh giữ được ý thức về phẩm giá mặc dù các vấn đề vệ sinh không tự chủ. Một thái độ bình tĩnh trấn an sẽ giúp giảm bớt cảm giác bối rối, xấu hổ.

Chăm sóc răng miệng

Vệ sinh răng miệng tốt có thể là một thách thức đối với những người SSTT . Đánh răng đôi khi khó khăn do không thể hiểu và chấp nhận sự trợ giúp từ người khác. Để giúp người bệnh cần lưu ý:

- Cung cấp hướng dẫn ngắn gọn, đơn giản.
- Sử dụng kỹ thuật làm mẫu: cầm bàn chải làm mẫu và chỉ cho cá nhân cách đánh răng.

Theo dõi chăm sóc răng miệng hàng ngày. Đánh răng hoặc làm vệ sinh răng giả sau mỗi bữa ăn và dùng chỉ nha khoa hàng ngày. Nếu người bệnh không chịu mở

miệng, hãy thử sử dụng các dụng cụ vệ sinh răng miệng, có thể nhờ nha sĩ hướng dẫn để miệng mở. Biểu cảm khuôn mặt căng thẳng trong bữa ăn hoặc từ chối ăn có thể cho thấy sự khó ở miệng.

Người chăm sóc rất cần thiết trong việc giúp người bệnh duy trì vệ sinh răng miệng, nếu nhận thấy bất kỳ vấn đề nào hãy tìm kiếm sự giúp đỡ từ nha sĩ. Thông báo trước cho nha sĩ rằng người đó bị SSTT để nha sĩ hướng dẫn cách chăm sóc răng miệng phù hợp.

LẬP KẾ HOẠCH CHĂM SÓC

Cần có kế hoạch chăm sóc lâu dài khi người thân của bạn được chẩn đoán bị sa sút trí tuệ. Bạn cần lên kế hoạch về tài chính và chuẩn bị những kỹ năng về chăm sóc và tâm lý. Những lo lắng về sự an toàn, dinh dưỡng, sức khỏe của người bệnh sẽ có lúc làm bạn thấy quá sức. Bạn cũng có thể cảm thấy tội lỗi và lo lắng quá mức vì bạn không thể ở đó mỗi ngày để xem người bệnh như thế nào.

Chúng tôi hy vọng sẽ cung cấp những lời khuyên về việc đưa ra và cân nhắc các kế hoạch chăm sóc dài hạn cho người bệnh.

1. Xác định những dịch vụ cần thiết

Nếu người mắc bệnh sống một mình, không có người thân cũng không có người để ủy quyền thực hiện những quyết định thì bản thân người bệnh cần lưu ý điều quan trọng là phải theo dõi khả năng của mình, quản lý các công việc hàng ngày. Cần có số điện thoại một người sẽ giám sát hay tổ chức hỗ trợ để giám sát tình trạng sức khỏe hoặc có kế hoạch đến các trung tâm chăm sóc trong tương lai. Nếu là người được giao quyền giám sát người bệnh, bạn cần phải lưu ý đánh giá người bệnh SSTT các vấn đề sau:

- Có tích trữ thực phẩm thích hợp và đầy đủ?
- Có nấu ăn hoặc tự chuẩn bị bữa ăn thường xuyên?
- Điều kiện của môi trường sống có bị thay đổi? (nhà cửa bề bộn không thể sinh hoạt, các vật dụng cá nhân không được sắp xếp...)
- Các hóa đơn (điện, nước ...) đã được thanh toán?
- Quên số nhà, số tài khoản, số liên lạc cần thiết?
- Bạn bè và người quen, người thân có ghé thăm thường xuyên không?
- Có duy trì các thói quen chăm sóc cá nhân như tắm rửa và mặc quần áo phù hợp?
- Có thể lái xe an toàn?

Nếu không thể giám sát hoặc người SSTT không thể trả lời các thông tin trên thì nên có hình thức hỗ trợ chăm sóc cho người bệnh.

2. Hãy nhờ người khác giúp đỡ

- Thành viên gia đình và bạn bè có thể hỗ trợ, sắp xếp lịch thăm mỗi tuần một

lần hoặc lâu hơn, tùy thuộc vào điều kiện của môi người.

- Hàng xóm, láng giềng, các tổ chức tại nơi cư trú. Lưu ý những người xung quanh quan sát, phát hiện bất cứ điều gì bất thường như mùi khói hoặc âm thanh báo động phát ra từ nhà của người bị SSTT.
- Nếu thực sự không có người thân hay không thể nhờ các tổ chức, nên xem xét việc đăng ký các viện dưỡng lão, các tổ chức hỗ trợ.

3. Cân nhắc kỹ trước khi đưa người bệnh về sống với bạn

Quyết định đưa người bệnh về sống với bạn cũng cần sự cân nhắc nhiều yếu tố chứ không đơn giản là để quản lý người bệnh trong sự giám sát của bạn. Dưới đây là một số điều cần suy nghĩ trước khi đưa người bệnh về sống với bạn:

- Người bệnh chuyển đến một mình hay có người chăm sóc (vợ/chồng người bệnh) đi cùng?
- Có thể tạo ra một không gian tương tự như nhà của người bệnh bằng cách sử dụng đồ đạc và sắp xếp vị trí tương đối giống không?
- Những đồ dùng thường sử dụng, vật kỉ niệm?
- Có đủ không gian cho người bệnh đến ở và không bị tranh chấp với người khác?
- Ai sẽ ở nhà để chăm sóc người bệnh?
- Các thành viên còn lại trong gia đình bạn hoặc những người cùng chung sống đã thống nhất về việc đưa người bệnh về ở chung chưa?
- Việc đưa người bệnh đến ở sẽ ảnh hưởng đến công việc, gia đình và tài chính của bạn như thế nào?
- Những dịch vụ nghỉ ngơi nào có sẵn để hỗ trợ bạn?

Đưa một người mắc bệnh SSTT ra khỏi môi trường quen thuộc có thể gây ra sự kích động và các triệu chứng của bệnh gia tăng. Trong một số tình huống, sắp xếp người chăm sóc hỗ trợ tại nơi người bệnh đang sinh sống có thể là một lựa chọn tốt hơn.

4. Chọn cơ sở chăm sóc

Cho dù người thân của bạn sống trong viện điều dưỡng, các cơ sở chăm sóc hay sống chung với bạn nhưng được người chăm sóc tại nhà thì điều quan trọng là người bệnh cần được duy trì liên lạc liên tục với các thành viên gia đình và bạn bè, tổ chức đưa người bệnh tái khám y tế theo lịch hẹn để được khám và điều trị theo phác đồ.

5. Giải quyết mâu thuẫn gia đình

Các vấn đề chăm sóc thường có thể châm ngòi hoặc làm trầm trọng thêm các

xung đột gia đình, đặc biệt là khi mọi người có thái độ khác nhau về việc chăm sóc người bệnh.

Các thành viên trong gia đình có thể phủ nhận những gì đang xảy ra, khiến bạn bức bối vì không tìm được sự thống nhất trong việc lựa chọn cách chăm sóc, không được hỗ trợ khi chăm sóc bệnh nhân. Cũng có thể có sự bất đồng về các quyết định tài chính hay các quyết định liên quan đến người bệnh.

Để giảm thiểu xung đột, hãy cố gắng thừa nhận những cảm xúc, những mâu thuẫn này và vượt qua chúng.

- Họp gia đình với các thành viên, chia sẻ quan điểm, cần có người có tiếng nói trong gia đình để thống nhất về kế hoạch chăm sóc. Nếu cần sự tư vấn của bác sĩ hay nhân viên y tế thì gia đình cần có thông tin hỗ trợ, lên lịch để được tư vấn cho các thành viên.
- Cần thông cảm và chia sẻ nhiệm vụ, có người có thể trực tiếp nhưng có người chỉ góp kinh phí hoặc tham gia có giới hạn. Bạn không thể bắt buộc tất cả các thành viên đều có thái độ trách nhiệm như nhau, chấp nhận điều này để cùng có giải pháp và không tạo ra thêm mâu thuẫn.
- Chia sẻ trách nhiệm chăm sóc: Lập danh sách các nhiệm vụ, bao gồm bao nhiêu thời gian, tiền bạc và công sức có thể được cùng tham gia để hoàn thành chúng. Phân chia nhiệm vụ theo sở thích và khả năng của các thành viên gia đình .
- Các cuộc họp gia đình định kỳ giúp gia đình luôn cập nhật và tham gia. Thảo luận về cách mọi thứ đang hoạt động, đánh giá lại nhu cầu của cả người mắc bệnh và người chăm sóc. Quyết định xem có cần thay đổi hay không?

Nhiều người chăm sóc cảm thấy có lỗi vì phải sống xa người bệnh SSTT. Cảm giác tội lỗi này, cộng với sự đau buồn liên quan đến việc nhìn thấy sự suy yếu của người thân, có thể gây khó khăn cho việc giải tỏa các mâu thuẫn hay chấp nhận thực tế. Điều quan trọng là tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình, bạn bè, cố vấn hoặc các chuyên khoa như tại Đơn vị trí nhớ và sa sút trí tuệ để giúp giải quyết những cảm xúc này.

6. Chăm sóc giai đoạn cuối

Thoải mái và tôn trọng - là những từ quan trọng để người chăm sóc ghi nhớ trong việc đảm bảo chất lượng cuộc sống trong giai đoạn cuối của bệnh nhân.

Tại thời điểm này người bệnh thường mất khả năng nói chuyện, đi lại và gặp khó khăn khi ăn uống, vệ sinh. Gia đình và nơi cung cấp dịch vụ chăm sóc đóng một vai trò quan trọng trong việc đưa ra các quyết định cho việc điều trị, những quyết định tôn trọng mong muốn cuối đời của người bệnh, đồng thời duy trì phẩm giá và sự thoải mái của họ.

Những quyết định thỏa thuận trước (theo nguyện vọng của người bệnh khi còn đủ khả năng ra quyết định).

Lý tưởng nhất là thảo luận về các vấn đề cuối đời nên diễn ra khi người bệnh vẫn có khả năng đưa ra quyết định.

Những người SSTT có quyền được yêu cầu hạn chế hoặc từ bỏ điều trị y tế, bao gồm sử dụng máy thở hỗ trợ hô hấp, hồi sức tim phổi, kháng sinh và dinh dưỡng tĩnh mạch để kéo dài sự sống. Những mong muốn này có thể được thể hiện thông qua các văn bản hoặc thỏa thuận với gia đình từ trước. Điều này hiện nay chưa có luật định nên cần phải có sự trao đổi thẳng thắn cùng các văn bản cụ thể để tránh những tranh chấp pháp lý về sau trong gia đình hoặc giữa gia đình với cơ sở y tế, cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc.

Hai hình thức phổ biến là thể hiện việc duy trì sự sống bằng các thiết bị can thiệp và cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe khi người bệnh không thể ra quyết định. Giấy ủy quyền cho phép người mắc bệnh chỉ định người thay thế, thường là thành viên gia đình đáng tin cậy, đưa ra quyết định cụ thể về việc điều trị thay cho người đó trong tương lai.

Các thành viên trong gia đình không nên đánh đồng việc từ chối hoặc rút điều trị, bao gồm điều trị các bệnh đe dọa đến tính mạng, sử dụng các thiết bị can thiệp (hồi sức tích cực khi ngưng tim ngưng thở, thở máy, chạy máy lọc máu liên tục, v.v.) như là đồng ý cho người bệnh tự tử hoặc hỗ trợ tự tử.

Nếu không có các quyết định trước hoặc không có ủy quyền, gia đình nên cố gắng đưa ra quyết định phù hợp với hoàn cảnh gia đình và cần có sự đồng thuận để tránh tổn thương trong gia đình cũng như mâu thuẫn với cơ sở y tế.

Truyền dung dịch nuôi dưỡng qua tĩnh mạch

Những người mắc bệnh cũng có thể từ chối ăn và uống. Những trường hợp như vậy nên được đánh giá để loại trừ các nguyên nhân bệnh lý như: suy thận, mất cân bằng chất lỏng và chất điện giải, phản ứng với thuốc....

Một trong những quyết định khó khăn hơn đối với các gia đình là liệu có nên truyền dung dịch nuôi dưỡng qua tĩnh mạch hay không. Việc bắt đầu sử dụng nuôi dưỡng tĩnh mạch ngoài gia tăng kinh phí còn hạn chế các hoạt động của bệnh nhân, tăng nguy cơ nhiễm trùng. Ngoài ra, nếu những biện pháp hỗ trợ này được sử dụng, các gia đình sẽ phải đối mặt với các quyết định khó khăn về việc có nên chấm dứt điều trị đó hay không.

Điều trị nhiễm trùng

Viêm phổi và nhiễm trùng đường tiết niệu là hai bệnh lý nhiễm trùng phổ biến trong giai đoạn cuối của bệnh, nếu người bệnh không thể nói chuyện, điều quan trọng là nhận biết các thay đổi để kịp thời đưa người bệnh đến cơ sở y tế.

- BN có thể có sốt hoặc không sốt
- Tăng tiết đàm nhớt, khó khăn trong hô hấp, hoạt động thể chất bị hạn chế.
- Tình trạng tri giác xấu hơn đột ngột, rối loạn ăn uống đột ngột

- Nước tiểu thay đổi màu sắc hoặc người bệnh tiểu rất nhất, than khó chịu, đau khi đi tiểu...

Cần lưu ý những than phiền của người bệnh và tái khám định kỳ hàng tháng để phát hiện có tình trạng nhiễm trùng hay không.

10 lời khuyên cho người chăm sóc



10 TIPS
FOR FAMILY CAREGIVERS



Tìm kiếm người hỗ trợ



Tự chăm sóc bản thân



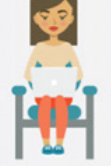
Chấp nhận/ đề nghị sự giúp đỡ của người khác



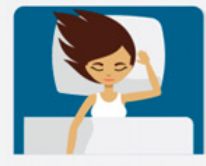
Học cách giao tiếp và thích ứng với thay đổi của người bệnh từ bác sỹ



Sử dụng các công cụ/ thiết bị trợ giúp



Tự phát hiện các dấu hiệu trầm cảm và không trì hoãn đi khám nếu có



Cần nghỉ ngơi hợp lý hồi phục sức khỏe



Sắp xếp thông tin y tế luôn được cập nhật và dễ tìm



Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ pháp lý liên quan đến bệnh nhân



Chuẩn bị kế hoạch tài chính cho việc chăm sóc người bệnh và duy trì việc làm của bản thân



CaregiverAction.org

CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH SA SÚT TRÍ TUỆ

Mỗi bệnh nhân SSTT sẽ có những thay đổi khác nhau tuy nhiên họ vẫn có thể duy trì chất lượng cuộc sống khi được điều trị bằng thuốc và có những can thiệp không dùng thuốc phù hợp với tình trạng của họ.

Thời gian mắc bệnh càng dài, nhu cầu hỗ trợ chăm sóc càng gia tăng, càng sâu rộng hơn.

Trách nhiệm của người chăm sóc bệnh nhân SSTT có thể bao gồm chăm sóc vệ sinh cá nhân, ăn uống, hỗ trợ trong mọi hoạt động hàng ngày của bệnh nhân. Người chăm sóc còn phải quản lý thuốc men, các ảnh hưởng do thay đổi hành vi, tính cách, đảm bảo an toàn của người bệnh. Trong một số trường hợp, cần có ủy quyền để người chăm sóc, thân nhân ra những quyết định có tính pháp lý thay cho bệnh nhân.

1. Chăm sóc hàng ngày

Khi sa sút trí tuệ tiến triển, người bệnh sẽ có những thay đổi tính cách, hành động. Không có cách chính xác để biết được những thay đổi này. Thân nhân và người chăm sóc tham khảo những thông tin sau đây để có thể đưa ra những phương pháp quản lý thói quen hàng ngày và bảo vệ sự an toàn của người bệnh.

Hoạt động hàng ngày: bao gồm mặc quần áo, chăm sóc vệ sinh cá nhân, các công việc trong gia đình kể cả việc mua sắm, thanh toán. Đối với người SSTT họ có thể cảm nhận sự khác biệt giữa được hỗ trợ chăm sóc một cách có tình cảm hay không và có thể phản ứng với điều đó nên người chăm sóc cần thấu hiểu để có sự tương tác hỗ trợ tích cực cho người bệnh.

Khi lập kế hoạch cho các hoạt động và công việc hàng ngày, hãy lưu ý:

- Người đó có những kỹ năng và khả năng gì?
- Người đó thích làm gì?
- Có phải người bắt đầu hoạt động mà không có định hướng gì?
- Người đó có vấn đề về thể chất, có bệnh lý gì cần lưu ý?

Cách tiếp cận:

- Làm cho các hoạt động là một phần của thói quen hàng ngày.
- Tập trung vào sự thoải mái không phải thành tích.
- Xác định thời gian nào trong ngày là tốt nhất cho hoạt động.
- Có sự hỗ trợ và giám sát.

- Hãy linh hoạt và kiên nhẫn, cùng tham gia, đừng căng thẳng yêu cầu kết quả.
- Giúp người bệnh cố gắng tự mình thực hiện các hoạt động
- Đơn giản hóa hướng dẫn, có làm mẫu là tốt nhất.
- Thiết lập thói quen duy trì trình tự các hoạt động hàng ngày.

Môi trường cho hoạt động:

- An toàn, quen thuộc với người bệnh.
- Thay đổi một số yếu tố môi trường xung quanh để khuyến khích các hoạt động và an toàn hơn nhưng không quá nhiều gây xa lạ.
- Giảm thiểu những phiền nhiễu làm người bệnh sợ hãi hoặc bối rối.

Cấu trúc hoạt động trong ngày

Hoạt động buổi sáng

- Vệ sinh cá nhân, đánh răng và mặc quần áo.
- Chuẩn bị và ăn sáng.
- Thảo luận về tờ báo hoặc hồi tưởng về những bức ảnh cũ.

Hoạt động buổi trưa và chiều

- Chuẩn bị và ăn trưa
- Dọn dẹp và rửa chén
- Nghỉ trưa
- Đọc báo, sách, thể dục.
- Nghe nhạc hoặc trò chơi ô chữ.
- Đi dạo.

Hoạt động buổi tối

- Chuẩn bị và ăn tối
- Viết nhật ký
- Tập thể dục
- Chơi bài hoặc xem phim.
- Đọc một cuốn sách hoặc tạp chí.

Tùy theo điều kiện gia đình, sở thích cá nhân mà các hoạt động trong ngày có thể thay đổi, nên tập thói quen hàng ngày cho người bệnh, thỉnh thoảng có thể có các hoạt động ngoài trời, mua sắm bên ngoài, giao lưu với những người cùng lứa tuổi hoặc bạn đồng nghiệp cũ... Tập thói quen viết nhật ký những hoạt động trong ngày cũng là một phương pháp tập luyện cho người bệnh vì vậy cần khuyến khích duy trì càng lâu dài càng tốt.

2. Giao tiếp

Những người SSTT thường khó thể hiện bản thân và hiểu người khác. Họ có thể:

- Gặp khó khăn trong việc tìm từ đúng, khó khăn trong việc sử dụng từ ngữ để diễn đạt, dùng câu nói diễn đạt
- Dùng từ quen thuộc nhiều lần.
- Phát minh từ mới để mô tả các đồ vật, khái niệm quen thuộc.
- Thường xuyên mất đi sự tư duy suy nghĩ.
- Quên ngoại ngữ, nói tiếng mẹ đẻ dù trước đây có thể sử dụng ngoại ngữ thông thạo.
- Sử dụng những lời xúc phạm nhưng không hề có suy nghĩ thiếu tôn trọng.
- Trở nên ít nói.
- Dựa vào cử chỉ không lời để giao tiếp.

Một số biện pháp để tăng cường giao tiếp:

- Cho thấy rằng bạn đang lắng nghe và cố gắng hiểu những gì đang được nói.
- Duy trì giao tiếp bằng mắt.
- Khuyến khích người bệnh tiếp tục bày tỏ suy nghĩ, cả khi họ gặp khó khăn.
- Cẩn thận đừng ngắt lời.
- Tránh chỉ trích, sửa chữa và tranh luận.
- Hãy bình tĩnh và hỗ trợ khi họ đang diễn đạt
- Sử dụng giọng điệu nhẹ nhàng, thoải mái.
- Sử dụng nét mặt tích cực, thân thiện.
- Luôn tiếp cận người đó từ phía trước, nói tên mình và gọi người đó bằng tên.
- Nói chậm rãi và rõ ràng.
- Sử dụng các từ ngắn gọn, đơn giản và quen thuộc.
- Chia các nhiệm vụ và hướng dẫn thành các bước rõ ràng, đơn giản.
- Hỏi một câu hỏi tại một thời điểm.
- Cho phép đủ thời gian cho một phản ứng.
- Tránh sử dụng đại từ chung, nên gọi theo tên của họ.
- Tránh sử dụng câu hỏi không có gợi ý và có khuynh hướng đánh giá tiêu cực (VD: Mẹ không biết đó là ai à? Cần thay là: Bác sĩ này là bác sĩ Nga, mẹ có nhớ không?)
- Sử dụng giao tiếp phi ngôn ngữ như chỉ vào, chạm vào...

- Hỗ trợ khi cần thiết.
- Đừng nói về người đó như thể người đó không ở đó.

Giao tiếp cần có sự kiên nhẫn, linh hoạt và thông cảm.

3. Trầm cảm

Trầm cảm là một nguyên nhân phổ biến của SSTT có thể điều trị, ở người trên 65 tuổi nguy cơ mắc bệnh trầm cảm cao hơn bốn lần so với những người trẻ tuổi. Khoảng 20% những người bệnh Alzheimer, 50% ở những người chăm sóc người Alzheimer và 15% người lớn trên 65 tuổi có triệu chứng trầm cảm.

Triệu chứng trầm cảm

Có thể mất hứng thú hoặc niềm vui trong các hoạt động, khó tập trung hoặc trải nghiệm, cảm giác tuyệt vọng và thấy mình vô giá trị. Họ có thể biểu hiện các triệu chứng thể chất như thay đổi khẩu vị, tăng cân và kiểu ngủ.

Sự hiện diện của ít nhất bốn trong số các triệu chứng sau trong khoảng thời gian hai tuần có thể cho thấy trầm cảm:

- 1) Tâm trạng chán nản hay cáu kỉnh
- 2) Cảm giác vô dụng hoặc mặc cảm quá mức
- 3) Suy nghĩ tự tử hoặc cố trường phạt bản thân
- 4) Kích động
- 5) Giấc ngủ bị ảnh hưởng xấu
- 6) Mệt mỏi và mất năng lượng
- 7) Mất hứng thú hoặc niềm vui trong các hoạt động thông thường
- 8) Khó suy nghĩ hoặc tập trung
- 9) Thay đổi khẩu vị và cân nặng

Điều trị trầm cảm

Nếu có triệu chứng trầm cảm, điều quan trọng là bạn phải đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và loại trừ bất kỳ nguyên nhân thực thể nào. Hiện tại không có một xét nghiệm chuyên biệt nào để xác định trầm cảm. Chẩn đoán liên quan đến việc đánh giá tiền sử bệnh, phỏng vấn người mắc bệnh và các thành viên gia đình, kiểm tra tình trạng tâm thần qua các test thần kinh tâm lý.

Điều trị trầm cảm có thể bao gồm một số kết hợp của thuốc, trị liệu, hỗ trợ tâm lý xã hội và các hoạt động thể chất, xã hội.

XỬ LÝ CÁC TÌNH HUỐNG PHÁT SINH TRONG CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH SA SÚT TRÍ TUỆ

1. Giám sát lạm dụng

Những người SSTT dễ bị lạm dụng bởi những người gần gũi hay là người chăm sóc với họ. Họ cũng có thể trở thành tầm ngắm cho những người lạ lợi dụng sự suy giảm nhận thức của họ để trục lợi, lừa đảo hay thậm chí là tấn công bạo lực.

Các loại lạm dụng:

- Thể chất - gây đau đớn hoặc tổn thương thực thể.
- Tình cảm - tấn công bằng lời nói, đe dọa lạm dụng, quấy rối và đe dọa.
- Giam giữ - kiềm chế hoặc cô lập người.
- Tài chính - việc lạm dụng hoặc giữ lại tài sản của người bệnh và cả gia đình của họ.
- Lạm dụng tình dục - khi người đó không thể hiểu, không muốn đồng ý hoặc bị đe dọa hoặc ép buộc về thể chất.
- Thiếu ý chí - cố tình từ chối thuốc men, chăm sóc y tế, thực phẩm, nơi ở hoặc hỗ trợ về thể chất, và do đó làm cho người mắc bệnh có nguy cơ bị tổn thương về thể chất, tinh thần hoặc cảm xúc.

Giải pháp đề xuất:

Những người chăm sóc - cả gia đình và chuyên gia - thường lại có thể trở thành người lạm dụng người bệnh. Trong nhiều trường hợp, căng thẳng và thất vọng có thể gây ra các hành động bạo lực không chủ ý ở những người chăm sóc với người bệnh. Những người chăm sóc có thể cảm thấy bị cô lập, chán nản và phẫn nộ với người bệnh khi căn bệnh tiến triển và có thể có hành vi lạm dụng mà không nhận ra điều đó. Các vấn đề khác, chẳng hạn như lạm dụng chất gây nghiện, vấn đề tình cảm, người bệnh quá phụ thuộc dẫn đến sự áp lực, cũng có thể dẫn đến ngược đãi.

Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc xử lý căng thẳng liên quan đến việc chăm sóc, điều quan trọng là nhận được sự hỗ trợ từ chuyên gia tâm lý, những thành viên trong gia đình. Cần thiết có thể tạm dừng công việc chăm sóc để tự chăm sóc chính mình.

2. Thay đổi hành vi

Bệnh SSTT có thể khiến bệnh nhân thể hiện những hành vi bất thường, không thể đoán trước, gây khó khăn cho những người chăm sóc. Những thay đổi hành vi cũng bao gồm thay đổi tâm lý nghiêm trọng như gây hấn bằng lời nói hoặc thể chất, đối

đầu, lặp lại từ ngữ và đi lang thang. Những thay đổi hành vi này có thể dẫn đến sự thất vọng và căng thẳng cho cả những người mắc bệnh và những người chăm sóc họ. Điều quan trọng cần nhớ là người bệnh không hành động có chủ đích, cần lưu ý để theo dõi, điều chỉnh sự chăm sóc và điều trị.

Nguyên nhân phổ biến của sự thay đổi hành vi:

- Khó chịu về thể chất do bệnh tật hoặc thuốc men.
- Quá kích thích từ một môi trường ồn ào hoặc hoạt động quá mức.
- Không có khả năng nhận ra những địa điểm, khuôn mặt hoặc đồ vật quen thuộc.
- Khó hoàn thành các nhiệm vụ hoặc hoạt động đơn giản.
- Không có khả năng giao tiếp hiệu quả.

Một số biện pháp để đối phó với các hành vi gây hấn:

- Bình tĩnh và thấu hiểu.
- Hãy kiên nhẫn và linh hoạt.
- Đừng tranh cãi hay cố gắng thuyết phục người đó.
- Công nhận yêu cầu và trả lời chúng.
- Cố gắng không có hành vi cá nhân
- Chấp nhận các hành động của người bệnh và cố gắng vượt qua nó.

Tìm hiểu nguyên nhân và giải pháp

- Nguyên nhân: Điều quan trọng là xác định nguyên nhân của hành vi thách thức và xem xét các giải pháp có thể.
- Các hành vi không mong muốn là gì? Nó có hại cho cá nhân hay người khác không?
- Điều gì đã xảy ra trước khi hành vi xảy ra và đã làm một cái gì đó kích hoạt nó?
- Một số giải pháp:
- Có một cái gì đó mà người bệnh cần hoặc muốn?
- Bạn có thể thay đổi môi trường xung quanh? Là khu vực ồn ào hay đông đúc? Phòng có được chiếu sáng tốt không?
- Bạn đang trả lời một cách bình tĩnh, bạn cần hỗ trợ?

3. Mất ngủ

Các vấn đề về giấc ngủ của những người SSTT và người chăm sóc kiệt sức là hai trong số những lý do phổ biến nhất khiến những người mắc bệnh được đưa vào viện dưỡng lão.

Một số gợi ý để giảm kích động buổi tối và mất ngủ vào ban đêm:

- Lên kế hoạch nhiều hoạt động trong ngày. Một người nghỉ ngơi hầu hết thời gian trong ngày có khả năng thức dậy vào ban đêm. Không khuyến khích ngủ trưa và lên kế hoạch cho các hoạt động, chẳng hạn như đi dạo, suốt cả ngày.
- Theo dõi chế độ ăn uống. Hạn chế đồ ngọt và caffeine vào buổi sáng. Ăn tối sớm (trước khi ngủ 3h) và chỉ có thể dùng thêm bữa ăn nhẹ trước khi đi ngủ.
- Kiểm tra sức khỏe, tái khám định kỳ hoặc khi có bất thường. Các bệnh lý, chẳng hạn như các vấn đề về bàng quang có thể gây khó ngủ do tiểu không tự chủ. Bác sĩ cũng có thể kê đơn thuốc để giúp người bệnh thư giãn vào ban đêm.
- Thay đổi cách sắp xếp phòng ốc, giường ngủ, cho phép người đó ngủ trong một phòng ngủ khác, trên một chiếc ghế yêu thích hoặc bất cứ nơi nào thoải mái nhất. Ngoài ra, giữ cho căn phòng có ánh sáng thích hợp với người bệnh để giảm kích động xảy ra khi môi trường xung quanh tối hoặc không quen thuộc.

Sự bồn chồn về đêm và tình trạng rối loạn giấc ngủ không kéo dài mãi mãi, nó thường đạt đến đỉnh điểm ở giai đoạn giữa, sau đó giảm dần khi bệnh tiến triển. Chính vì vậy trong giai đoạn này, người chăm sóc nên đảm bảo sự an toàn, đặc biệt là nếu người bệnh mắc Alzheimer . Hạn chế người bệnh có thể đi vào một số phòng nhất định bằng cách đóng khóa cửa, lắp đặt hệ thống báo hoặc khóa chỉ có thể mở một chiều. Cảm biến cửa và máy dò chuyển động có thể được sử dụng để cảnh báo các thành viên trong gia đình khi một người đang đi lang thang.

4. Lang thang

Một người SSTT có khả năng bị mất phương hướng và đi lang thang vào một lúc nào đó. Hơn 60% những người mắc bệnh có rối loạn hành vi đi lang thang. Xác định nguyên nhân của hành vi có thể giúp loại bỏ hoặc giảm sự xuất hiện của nó. Nhận thức về vấn đề để quản lý bệnh nhân giúp giảm thương tích và tử vong.

Dấu hiệu cảnh báo cho lang thang:

1. Trở về nhà muộn hơn bình thường.
2. Cố gắng thực hiện việc di chuyển trước đây khó khăn hơn vì định hướng không đúng
4. Bồn chồn hoặc làm cho chuyển động lặp đi lặp lại.
5. Gặp khó khăn trong việc định vị những nơi quen thuộc như phòng tắm, phòng ngủ hoặc phòng ăn.
6. Quên hay thường xuyên hỏi về nơi ở những người quen thuộc.
7. Hành vi như thể làm một việc nhưng không có gì được thực hiện (ví dụ như di chuyển xung quanh chậu cây mà không thực sự trồng bất cứ thứ gì).
8. Đi đến những nơi xa lạ mà không có mục đích.

Nguyên nhân:

Đi lang thang có thể được gây ra bởi một số yếu tố, bao gồm:

- Tác dụng phụ của thuốc.
- Căng thẳng.
- Nhầm lẫn liên quan đến thời gian.
- Bồn chồn, lo lắng.
- Kích động.
- Không có khả năng nhận ra người, địa điểm và đối tượng quen thuộc.
- Sợ hãi phát sinh từ việc giải thích sai các điểm tham quan và âm thanh.
- Mong muốn thực hiện công việc trước đây, chẳng hạn như đi làm hoặc đi mua sắm, công việc.

Một số gợi ý giảm hành vi lang thang:

- Khuyến khích vận động và tập thể dục để giảm lo lắng, kích động và bồn chồn.
- Thu hút người tham gia vào các hoạt động hàng ngày hiệu quả, chẳng hạn như gấp quần áo hoặc chuẩn bị bữa ăn.
- Đặt gương gần cửa ra vào để có thể quan sát người bệnh khi muốn đi ra ngoài, giúp người chăm sóc kịp thời hỗ trợ người bệnh, ngăn cản họ.
- Hãy trấn an người đó nếu cảm thấy bị mất, bị bỏ rơi hoặc mất phương hướng.

Lời khuyên để bảo vệ người thân đi lang thang:

- Thông báo cho hàng xóm và địa phương về tình trạng của người đó. Cho số liên hệ của gia đình cũng như danh sách tên và số điện thoại để khi người bệnh đi lang thang có thể được phát hiện và thông báo.
- Giữ cho ngôi nhà của bạn an toàn bằng cách cài đặt khóa chốt hoặc chốt trượt trên cửa bên ngoài và hạn chế người bệnh có thể đi ra ngoài mà không có người hỗ trợ.
- Lưu ý rằng người đó không chỉ đi lang thang mà còn đi dùng các phương thức vận chuyển khác gây ra nguy hiểm cho bản thân và những người xung quanh.

Khi lập kế hoạch cho các hoạt động và công việc hàng ngày, hãy lưu ý:

- Người đó có những kỹ năng và khả năng gì?
- Người đó thích làm gì?
- Có phải người bắt đầu hoạt động mà không có định hướng gì?
- Người đó có vấn đề về thể chất, có bệnh lý gì cần lưu ý?

Cách tiếp cận:

- Làm cho các hoạt động là một phần của thói quen hàng ngày.

- Tập trung vào sự thoải mái không phải thành tích.
- Xác định thời gian nào trong ngày là tốt nhất cho hoạt động.
- Có sự hỗ trợ và giám sát.

NHẬN BIẾT VÀ XỬ LÝ THAY ĐỔI MỐI QUAN HỆ CỦA NGƯỜI BỆNH VỚI NGƯỜI XUNG QUANH

Người mắc bệnh sẽ có những thay đổi trong mối quan hệ với các thành viên gia đình và bạn bè. Người chăm sóc cần lưu ý để hỗ trợ cho người bệnh và những người xung quanh không bị mâu thuẫn hay tổn hại.

1. Sự thân mật

Đây là điều rất nhạy cảm và khó chia sẻ nhưng chúng tôi vẫn cố gắng thông tin trong hướng dẫn này với mong muốn người chăm sóc cần chuẩn bị cho tất cả những thay đổi trong cuộc sống của mình kể cả những điều riêng tư nhất, khi bạn là vợ/chồng của người bị SSTT. Càng né tránh hay e ngại khi chia sẻ những vấn đề này thì những khó khăn và áp lực càng nặng nề mà bạn không cần thiết phải mang chúng.

Bạn có thể cảm thấy lo lắng, hoang mang về những thay đổi trong mối quan hệ của bạn. Bạn không ích kỷ khi trải qua những cảm giác này. Với sự suy giảm nhận thức của vợ/chồng của bạn, bạn có thể không còn có thể có sự thân mật về cảm xúc hoặc thể chất như bạn từng chia sẻ.

Điển hình là những người bệnh trải qua những thay đổi trong ham muốn tình dục. Trầm cảm có thể gây giảm hứng thú trong tình dục. Một bệnh thể chất và phản ứng với thuốc cũng có thể làm giảm ham muốn tình dục. Ngược lại, cũng có trường hợp người mắc bệnh có những biểu hiện hành vi không phù hợp và tăng ham muốn tình dục. Phản ứng với vợ/chồng của bạn cần sự kiên nhẫn và dịu dàng. Nên thể hiện tình cảm quan tâm với những cái ôm hoặc nắm tay. Trong nhiều trường hợp, người bệnh có thể chỉ đơn giản là lo lắng và cần sự trấn an thông qua giao tiếp nhẹ nhàng, yêu thương và sự thân mật trong cử chỉ.

2. Gia đình và bạn bè

Người chăm sóc có thể cảm thấy bị cô lập về mặt xã hội vì gia đình và bạn bè hoặc cảm thấy bạn có ít thời gian để dành cho họ hoặc thấy e ngại việc bạn phải chăm sóc một người SSTT. Gia đình và bạn bè của người chăm sóc có thể ngần ngại dành thời gian cho bạn và người bệnh vì họ lo lắng về việc không biết phải làm gì hoặc nói gì. Họ cũng có thể không hiểu những thay đổi hành vi gây ra bởi bệnh hoặc không thể chấp nhận rằng người đó mắc bệnh.

Hãy chủ động liên lạc với gia đình và bạn bè và giải thích lý do đã thay đổi cuộc sống của bạn theo một số cách, bạn đánh giá cao tình bạn và sự hỗ trợ của họ.

Xem xét việc mời một vài người bạn hoặc thành viên gia đình đến thăm, cùng dùng bữa hoặc có những hoạt động kỉ niệm. Cho họ biết trước bất kỳ thay đổi về thể chất hoặc cảm xúc ở người sa sút trí tuệ. Giải thích về cách giao tiếp với người bệnh và

những hoạt động nào họ có thể làm cùng nhau.

3. Giải quyết mâu thuẫn gia đình

Các vấn đề chăm sóc thường có thể châm ngòi hoặc phóng đại các xung đột gia đình, đặc biệt là khi mọi người có cách nhìn khác nhau khi phải đối mặt với trách nhiệm chăm sóc.

Thành viên gia đình có thể từ chối những gì đang xảy ra hoặc phẫn nộ thậm chí lên án những thành viên gia đình sống xa hoặc không giúp đỡ việc chăm sóc. Cũng có thể có sự bất đồng về các quyết định tài chính và chăm sóc.

Để giảm thiểu xung đột, hãy cố gắng chấp nhận những cảm xúc này và có giải pháp vượt qua chúng.

- **Họp gia đình:** Nói về vai trò và trách nhiệm chăm sóc, các vấn đề và cảm xúc có thể giúp giảm bớt căng thẳng. Gia đình có thể muốn giúp đỡ từ một cố vấn chuyên nghiệp hoặc người mà gia đình tin tưởng.
- **Lập kế hoạch:** Một số thành viên gia đình có thể là người chăm sóc, phản hồi ngay lập tức các vấn đề và đề nghị có kế hoạch về tài chính, người tham gia.... những người khác có thể thoải mái hơn với việc được yêu cầu hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể chứ không tham gia chăm sóc trực tiếp.
- **Chia sẻ trách nhiệm chăm sóc:** Lập danh sách các nhiệm vụ bao gồm cụ thể bao nhiêu thời gian, tiền bạc và công sức để hoàn thành chúng. Phân chia nhiệm vụ phù hợp sở thích và khả năng của các thành viên gia đình.
- **Duy trì liên lạc:** Các cuộc họp gia đình để giúp luôn cập nhật thông tin và cùng tham gia trong việc chăm sóc. Thảo luận về cách mọi thứ đang hoạt động, đánh giá lại nhu cầu của cả người bệnh và người chăm sóc, và quyết định xem có cần thay đổi trách nhiệm hay không.

4. Một số cảm xúc đau buồn, mất mát, tiêu cực

Nếu bạn là một người chăm sóc, bạn có thể trải nghiệm cảm giác hay cảm xúc tiêu cực, mất mát, đặc biệt là khi cuộc sống của bạn và người thân của bạn bị thay đổi bởi căn bệnh SSTT. Các giai đoạn tự nhiên của đau buồn thường liên quan đến sự từ chối, tức giận, cảm giác tội lỗi, các triệu chứng thể chất và cuối cùng là sự chấp nhận. Tuy nhiên, điều quan trọng cần phải biết rằng mỗi người sẽ có những phản ứng, những cảm xúc rất khác nhau, không có công thức chung cho cảm xúc.

Các biểu hiện:

- Từ chối rằng người thân của bạn bị bệnh.
- Có cảm giác bất lực, tuyệt vọng và chán nản.
- Thay đổi khẩu vị hoặc giấc ngủ.

- Cảm giác tức giận hoặc thất vọng với người bệnh và với các nhiệm vụ chăm sóc.
- Rút khỏi các hoạt động xã hội, bạn bè, gia đình và né tránh hoặc chỉ quan tâm người bạn chăm sóc.
- Cảm giác tội lỗi: thường là cảm giác phổ biến nhất đối với những người chăm sóc. Cảm giác tội lỗi có thể liên quan đến:

《 Nghĩ rằng bạn có thể đã làm một cái gì đó khác tốt hơn.

《 Có thể tận hưởng cuộc sống trong khi người thân yêu của bạn thì không (người bệnh).

《 Cảm giác rằng bạn đã thất bại, đặc biệt là nếu người bệnh được đưa vào viện dưỡng lão.

《 Những suy nghĩ tiêu cực về người mắc bệnh - mong muốn rằng sự đau khổ của người đó sẽ chấm dứt.

《 Xung đột với các thành viên trong gia đình vì họ không giải quyết được hoặc phê phán sự chăm sóc của bạn.

Lời khuyên:

Để đối phó với quá trình đau buồn, cảm giác tội lỗi hãy thử thực hiện các bước hành động sau:

- Đối mặt với cảm xúc của bạn.
- Chấp nhận mặc cảm như một phần bình thường của sự mất mát và đau buồn.
- Tìm cách tha thứ cho chính mình.
- Chia sẻ cảm xúc của bạn với bạn bè, nhóm hỗ trợ, nhà trị liệu hoặc tôn giáo.
- Học cách cảm thấy thoải mái khi chấp nhận và tôn vinh những điều tốt đẹp trong cuộc sống của bạn.

Nếu đau buồn kéo dài hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến mức sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn, hãy tìm kiếm sự giúp đỡ từ bác sĩ. Có nhiều cách bạn có thể bắt đầu để thư giãn hơn:

- Trở lại một số khía cạnh của thói quen hàng ngày của bạn.
- Cho phép thời gian tập thể dục, chơi và nghỉ ngơi.
- Cố gắng tìm sự hài hước - ngay cả trong những tình huống khó khăn.
- Mang lại sự cân bằng cho cuộc sống của bạn bằng cách làm những việc mà bạn thích.
- Chuẩn bị cho những gì tương lai có thể đòi hỏi.

5. Trao đổi với người trẻ trong gia đình khi có người thân bị sa sút trí tuệ

Khi gia đình có người bị SSTT, không chỉ có người bệnh và người chăm sóc sẽ bị ảnh hưởng mà tất cả các thành viên trong gia đình đều bị ảnh hưởng lớn. Cần lưu ý dành thời gian để nói chuyện với trẻ em và thanh thiếu niên trong gia đình để các em hiểu những gì đang xảy ra với người bệnh, nhất là khi SSTT do bệnh Alzheimer. Mức độ mà trẻ em và thiếu niên bị ảnh hưởng bởi căn bệnh này phụ thuộc vào người bệnh là cha mẹ hay ông bà của các em, là người thân hoặc bạn bè của các em. Các yếu tố khác bao gồm mức độ gần gũi của đứa trẻ hoặc thanh thiếu niên với người bị bệnh và nơi người đó sống (trong cùng một nhà hay viện dưỡng lão, ở gần nhau hay ở xa..)

Cảm giác và phản ứng: Trẻ em và thiếu niên có thể cảm thấy:

- Buồn về những thay đổi trong tính cách và hành vi của người thân yêu.
- Bối rối hoặc sợ hãi tại sao người đó cư xử khác thường.
- Lo lắng rằng căn bệnh này dễ lây lan và sẽ mắc phải nó.
- Lo lắng rằng cha mẹ, ông bà (nếu người bệnh không phải là cha mẹ, ông bà) của các em có thể bị bệnh.
- Tức giận và thất vọng vì cần phải lặp lại các hoạt động hoặc câu hỏi.
- Có lỗi vì tức giận hoặc nóng nảy với người đó.
- Ghen tuông và bực bội vì số lượng tăng thời gian và sự chú ý được trao cho người bệnh.
- Xấu hổ khi có bạn bè hoặc những người khách khác đến nhà.

Trẻ em và thiếu niên có thể thể hiện cảm xúc của mình theo những cách mà bạn có thể không nhận ra:

- Thường xuyên than phiền thể chất có vấn đề như đau đầu, đau bụng...
- Học kém.
- Ít tiếp xúc, né tránh việc mời bạn bè đến nhà.

Cách giúp trẻ em và thiếu niên tiếp nhận:

- Duy trì các cách giao tiếp giữa các em với người bệnh, với tất cả thành viên gia đình.
- Cung cấp sự thoải mái và hỗ trợ, tạo cơ hội cho các em bày tỏ tình cảm.
- Hãy cho các em biết cảm xúc của các em là bình thường.
- Giáo dục họ về căn bệnh này và khuyến khích họ đặt câu hỏi.
- Trả lời trung thực các câu hỏi.
- Làm các công việc gia đình với nhau, chẳng hạn như gấp quần áo, cùng dọn bàn ăn hoặc rửa chén, nghe nhạc, nhảy hoặc hát cùng nhau.

- Cùng xem những bức ảnh cũ của cả gia đình.
- Phát triển một cuốn sách về cuộc đời của người bệnh sa sút trí tuệ.
- Làm cây gia đình, nhắc về mối quan hệ.
- Có một số hoạt động giải trí bên ngoài cùng nhau.

NHỮNG ĐIỀU NGƯỜI CHĂM SÓC CẦN LÀM CHO BẢN THÂN

Chăm sóc cho người bệnh sa sút trí tuệ có thể là quá sức, mệt mỏi và căng thẳng. Một người là thành viên trong gia đình đảm nhận nhiệm vụ này có thể cảm thấy mất mát vì những thay đổi trong mối quan hệ với người thân bị bệnh, các thành viên khác trong gia đình và bạn bè. Trong thời gian này, điều quan trọng là những người chăm sóc cũng cần lưu ý đến sức khỏe thể chất và tinh thần của chính họ.

1. Sức khỏe của người chăm sóc

Rất nhiều người thực hiện các nhiệm vụ chăm sóc người khác trong khi bỏ bê sức khỏe thể chất, tinh thần và cảm xúc của chính mình. Các câu hỏi sau đây có thể giúp bạn xác định xem bạn có đang gặp vấn đề về sức khỏe hay không:

Bạn có khám định kỳ hàng năm không?

Điều tốt nhất bạn có thể làm cho người mắc bệnh sa sút trí tuệ là giữ sức khỏe chính mình để chăm sóc họ tốt nhất có thể. Tôn trọng những gì cơ thể bạn đang nói với bạn. Kiệt sức, căng thẳng, mất ngủ, rối loạn ăn uống hoặc hành vi là những dấu hiệu không thể xem thường. Bỏ qua những triệu chứng này có thể khiến sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn suy giảm trầm trọng.

Bạn có chấp nhận sự giúp đỡ từ người khác không?

Bạn không thể làm mọi thứ. Cố gắng tự xử lý mọi thứ sẽ chỉ dẫn đến kiệt sức, chán nản và oán giận đối với chính mình. Bạn không thất bại với tư cách là người chăm sóc bằng cách nhờ người khác giúp đỡ. Khi bạn bè và gia đình đề nghị giúp đỡ hãy chấp nhận nó như một món quà của tất cả các bên. Cũng xem xét các giải pháp chăm sóc do các cơ sở bên ngoài cung cấp để có sự nghỉ ngơi phù hợp.

Bạn có nói chuyện với người khác về cảm xúc của bạn không?

Bạn có thể nghĩ rằng không ai hiểu những gì bạn đang trải qua. Giữ trong bạn những vấn đề riêng, tuy nhiên, điều đó sẽ chỉ khiến bạn cảm thấy bị cô lập và bị lãng quên về mặt cảm xúc. Chia sẻ kinh nghiệm của bạn với người khác có thể giúp bạn thấy mình được giải tỏa, nhiều cái nhìn tích cực hơn và có khi bạn giúp đỡ được người khác cũng chính là giúp chính mình có niềm vui.

Sáu bước đơn giản bạn có thể thực hiện để đảm bảo rằng bạn là một người chăm sóc biết quan tâm sức khỏe chính mình:

1. Gặp bác sĩ khám định kỳ cũng như khi có bất cứ vấn đề về tâm lý, thể chất cần hỗ trợ của chuyên gia y tế.
2. Được kiểm tra để tầm soát trầm cảm, rối loạn lo âu.

3. Nghỉ ngơi nhiều hơn.
4. Ăn các bữa ăn đủ dinh dưỡng, đúng giờ.
5. Luyện tập thể dục đều đặn.
6. Chấp nhận sự giúp đỡ từ người khác.

2. Những dấu hiệu người chăm sóc bị căng thẳng

Nhiều báo cáo trong và ngoài nước cho thấy, hơn 80% những người chăm sóc thường xuyên trải qua những giai đoạn căng thẳng, và gần 50% nói rằng họ bị trầm cảm. Nhiều người chăm sóc không nhận ra nhu cầu của họ, không làm bất cứ điều gì cho bản thân hoặc chỉ đơn giản là không biết nơi nào để tìm sự giúp đỡ. Quá nhiều căng thẳng có thể gây tổn hại cho những người chăm sóc và cả cho người bệnh sa sút trí tuệ.

Nếu bạn là một người chăm sóc đang gặp phải các triệu chứng căng thẳng thường xuyên, đừng ngần ngại tham khảo ý kiến bác sĩ. Bạn cũng có thể tìm kiếm sự tư vấn chuyên nghiệp để có một không gian an toàn và riêng tư để trao đổi về những mối quan tâm của bạn.



Những dấu hiệu cảnh báo căng thẳng của người chăm sóc:

- Từ chối giúp đỡ, hỗ trợ hoặc những tiếp xúc của người xung quanh.
- Giận dữ, bực bội.
- Xa lánh xã hội.
- Lo lắng, căng thẳng.
- Phiền muộn.

- Cảm giác kiệt sức.
- Mất ngủ.
- Cáu gắt.
- Thiếu tập trung.
- Có những vấn đề sức khỏe thực thể.

Những cách hỗ trợ giảm căng thẳng cho người chăm sóc:

- Biết tận dụng những nơi cung cấp dịch vụ chăm sóc tạm thời cho người bệnh và những nơi để bạn có thể nghỉ ngơi.
- Hiểu biết về bệnh SSTT và các kỹ thuật chăm sóc.
- Nhận trợ giúp từ gia đình, bạn bè và các hỗ trợ của cơ sở y tế.
- Chăm sóc bản thân - có được dinh dưỡng tốt, tập thể dục và nghỉ ngơi nhiều.
- Tự quản lý sự căng thẳng của bạn bằng cách sử dụng các kỹ thuật thư giãn.
- Chấp nhận những thay đổi khi chúng xảy ra.
- Lập kế hoạch cho các vấn đề pháp lý và tài chính của người bệnh để tránh xử lý chúng trong tình huống khủng hoảng.
- Đánh giá thực tế về những gì bạn có thể làm trong việc chăm sóc người bệnh cũng như vai trò của bạn đối với gia đình, với người bệnh.
- Hãy tự đánh giá tốt cho những gì bạn đã hoàn thành; đừng cảm thấy tội lỗi nếu bạn mất kiên nhẫn hoặc không thể tự mình làm mọi việc.
- Kết nối với những người chăm sóc khác bằng cách liên lạc, chia sẻ với nhau khi đưa người bệnh đến điều trị tại cơ sở y tế (như khi hoạt động trị liệu nhóm tại Đơn vị trí nhớ và sa sút trí tuệ). Bạn có thể chia sẻ kinh nghiệm với những người khác biết chính xác những gì bạn đã và đang trải qua.

3. Nguy cơ trầm cảm của người chăm sóc

Những cảm xúc căng thẳng, giận dữ, tội lỗi, đau buồn liên quan đến việc chăm sóc có thể dẫn đến trầm cảm. Người chăm sóc có thể trải qua trầm cảm tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình chăm sóc người bệnh. Nếu cảm thấy đang trải qua trầm cảm, hoặc có những cảm xúc, suy nghĩ ảnh hưởng đến cả sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn, hãy tìm kiếm sự giúp đỡ ngay lập tức từ bác sĩ.

Triệu chứng trầm cảm:

Sự hiện diện của ít nhất bốn trong số các triệu chứng sau trong khoảng thời gian hai tuần có thể cho thấy trầm cảm:

- Tâm trạng chán nản hay cáu kỉnh.
- Cảm giác vô dụng hoặc mặc cảm quá mức.

- Suy nghĩ tự tử.
- Hành vi chậm chạp hoặc kích động.
- Rối loạn giấc ngủ.
- Mệt mỏi và mất năng lượng.
- Mất hứng thú hoặc niềm vui trong các hoạt động thông thường.
- Khó suy nghĩ hoặc tập trung.
- Thay đổi khẩu vị và cân nặng.

Điều trị:

Nếu có triệu chứng trầm cảm, điều quan trọng là bạn phải đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và loại trừ bất kỳ nguyên nhân thực thể nào. Hiện tại không có một xét nghiệm chuyên biệt nào để xác định trầm cảm. Chẩn đoán liên quan đến việc đánh giá tiền sử bệnh, phỏng vấn người mắc bệnh và các thành viên gia đình, kiểm tra tình trạng tâm thần qua các kiểm tra thần kinh tâm lý.

Điều trị trầm cảm có thể bao gồm một số kết hợp của thuốc, trị liệu, hỗ trợ tâm lý xã hội và các hoạt động thể chất, xã hội. Nếu thực sự bị trầm cảm, việc chăm sóc của bạn với người bị SSTT phải cần được cân nhắc, cần có sự hỗ trợ của gia đình hoặc đưa người bệnh đến các trung tâm, đơn vị trí nhớ và sa sút trí tuệ để chăm sóc trong một thời gian, giúp bạn có thể ổn định tình trạng sức khỏe.

MỘT SỐ TRANG ĐIỆN TỬ THAM KHẢO

Website hướng dẫn một số tình huống thực tế khi chăm sóc BN sa sút trí tuệ và cách giải quyết

www.youtube.com/watch?v=hahvUXwTXE4

Facebook của Đơn vị trí nhớ và Sa sút trí tuệ Bệnh viện 30-4

www.facebook.com/DonviTrinhovaSasuttritueBV304

CLB Hỗ trợ người chăm sóc bệnh nhân Sa sút trí tuệ/Alzheimer

www.facebook.com/groups/CLB.ho.tro.nguoi.cham.soc.BN.SSTT.Alzheimer

Website của Hiệp hội Alzheimer Quốc tế

www.alz.org/asian/about/what_is_alzheimers.asp?nL=VI&dL=VI

Website Hội bệnh Alzheimer và rối loạn nhận thức Việt Nam

<http://alzvietnam.org/goc-benh-nhan/-38.html>

LỜI CẢM ƠN

TS. BS Trần Công Thắng Phó chủ nhiệm bộ môn nội thần kinh trường Đại học Y được Tp Hồ Chí Minh, cố vấn chuyên môn Đơn vị trí nhớ và Sa sút trí tuệ Bệnh viện 30/4

PhD. Sarah Antonia Wescheke Chuyên gia tâm lý Trung tâm bệnh lý và thoái hóa thần kinh CHLB Đức (DZNE)

TS. BS Nguyễn Thị Thái An Đơn vị trí nhớ và Sa sút trí tuệ Bệnh viện 30/4

BS Lê Thu Nga Đơn vị trí nhớ và Sa sút trí tuệ Bệnh viện 30/4

BS Trần Thị Thu Hương Đơn vị trí nhớ và Sa sút trí tuệ Bệnh viện 30/4

BS Phạm Thị Thanh Tâm Đơn vị trí nhớ và Sa sút trí tuệ Bệnh viện 30/4

BS Đỗ Thanh Liêm Đơn vị trí nhớ và Sa sút trí tuệ Bệnh viện 30/4

MD. PhD Ingo Kilimann Trung tâm bệnh lý và thoái hóa thần kinh DZNE Rostock/ Greifswald

PhD. Sarah Antonia Weschke Trung tâm bệnh lý và thoái hóa thần kinh DZNE Rostock/ Greifswald

Mrs. Henrike Pfaff Trung tâm bệnh lý và thoái hóa thần kinh DZNE Rostock/ Greifswald

Toàn thể các thành viên của Đơn vị trí nhớ và Sa sút trí tuệ Bệnh viện 30/4 đã góp phần xây dựng nên tài liệu này.

Hải Âu đã giúp đỡ tìm nguồn tài trợ để cuốn sách đến được tay bạn đọc.

Xin cảm ơn tất cả mọi người.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1/ Thông tin về sa sút trí tuệ, 2017 – Bolton Clarke.

www.boltonclarke.com.au/languages/vietnamese/

2/ Thông tin sa sút trí tuệ, 2017, Dementia Australia

www.dementia.org.au/files/helpsheets/Helpsheet-AboutDementia01-WhatIsDementia_vietnamese.pdf

3/ Hướng dẫn cho người chăm sóc hiếu hành vi sa sút trí tuệ, 2016, Liên-hiệp người chăm sóc gia đình (Family Caregiver Alliance).

www.caregiver.org/h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-cho-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-ch%C4%83m-s%C3%B3c-v%E1%BB%81-hi%E1%B-%B83u-h%C3%A0nh-vi-sa-s%C3%BAt-tr%C3%AD-tu%E1%BB%87-car-egiver%E2%80%99s-guide-understanding-dementia

4/ Chương trình hỗ trợ người chăm sóc của bang Oregon (Mỹ) 2014, 2016

www.oregon.gov/DHS/SENIORS-DISABILITIES/SUA/Pages/ADRC-Dementia-Training.aspx

5/ Living with dementia, 2011, German Alzheimer Society and the DZNE Rostock/Greifswald.

GHI CHÚ CÁ NHÂN

[illegible]

[illegible]

